

INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS



ROTINA CLÍNICA

Modelos de prescrição

RESFRIADO

- **Uso oral:**

Dipirona 500 mg ---- 20 comprimidos

Tomar de 1 a 2 comprimidos de 6/6h em caso de dor e/ou febre.

(Pode utilizar paracetamol no lugar da dipirona, mantendo mesma dose e posologia).

Ibuprofeno 600 mg ---- 15 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8/8h em caso de dor forte e refratária à dipirona/paracetamol (fazer uso por no máximo 5 dias).

Loratadina 10 mg ---- 07 comprimidos

Tomar 01 comprimido à noite por até 7 dias em caso de tosse.



RESFRIADO

- **Uso oral:**

Soro de reidratação oral ---- 5 sachês

Diluir o conteúdo de 1 sachê em 1 litro de água filtrada. Conservar solução em geladeira. Tomar ao longo do dia.

(A validade desta solução é 24 horas).

- **Uso tópico (nasal):**

Soro fisiológico 0,9% ---- 1 frasco

Lavar narinas ao menos 4 vezes ao dia por 5 dias.

Budesonida spray nasal 32 ou 50 mcg ---- 1 frasco

Aplicar 2 jatos em cada narina à noite por 7 dias.



RESFRIADO

Detalhe: esse modelo de prescrição também é adequado para pacientes com gripe ou outras infecções de vias aéreas superiores (IVAS) de etiologia viral.

Orientações:

Orientar paciente a procurar atendimento médico caso piora e/ou não melhora dos sintomas.

Manter hidratação oral adequada (entre 2 a 3 litros/dia).

Atenção caso exista restrição hídrica por alguma comorbidade (insuficiência cardíaca, doença renal crônica, etc.).



TOSSE PÓS-VIRAL

Condição também denominada de tosse pós-infecciosa. Sua duração pode se estender por até **8 semanas** após a resolução do resfriado.

- **Uso oral:**

Dexclorfeniramina 2 mg ---- 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8/8h em caso de tosse.

Codeína 30 mg ---- 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido até de 6/6h em caso de tosse persistente. **Para prescrever a codeína, usar receita branca especial C1.**

- **Uso tópico (nasal):**

Budesonida 32 ou 50 mcg ---- 1 frasco
Administrar 1 jato em cada narina, de 12/12h, por até 7 dias.



SINUSITE

- **Uso oral (antimicrobianos):**

Amoxicilina+clavulanato (500+125 mg) ---- 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8/8h por 10 dias.

Ou

Amoxicilina+clavulanato (875+125 mg) ---- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 10 dias.

Ou

Levofloxacino 750 mg ---- 07 comprimidos

Tomar 1 comprimido 1 vez ao dia por 7 dias.

Também devem ser receitados sintomáticos e lavagem nasal com SF 0,9%.



ROTINA CLÍNICA

FARINGOAMIGDALITE

- **Uso oral (antimicrobianos):**

Amoxicilina+clavulanato (500+125 mg) ---- 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8/8h por 10 dias.

Ou

Azitromicina 500 mg ---- 5 comprimidos

Tomar 1 comprimido uma vez ao dia por 5 dias.

- **Uso IM (antimicrobiano):**

Penicilina G benzatina 1.200.000 UI ---- 1 ampola

Administrar o conteúdo de 1 ampola, via IM, em dose única.



ROTINA CLÍNICA

PNEUMONIA

Paciente sem comorbidades, sem uso recente de antibióticos nos últimos 3 meses, sem fator de risco para resistência.

- **Uso oral (antimicrobianos):**

Amoxicilina+clavulanato (500+125 mg) ---- 21 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8/8h por 7 dias.

Ou

Azitromicina 500 mg ---- 5 comprimidos

Tomar 1 comprimido uma vez ao dia por 5 dias.



ROTINA CLÍNICA

PNEUMONIA

Com fatores de risco, doença mais grave e uso recente de ATB (últimos 3 meses).

- **Uso oral:**

Amoxicilina+clavulanato (500+125 mg) ---- 21 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8/8h por 7 dias.

E

Azitromicina 500 mg ---- 5 comprimidos

Tomar 1 comprimido uma vez ao dia por 5 dias.

Ou

Levofloxacino 750 mg ---- 7 comprimidos

Tomar 1 comprimido 1 vez ao dia por 7 dias.



ROTINA CLÍNICA

PNEUMONIA

Para os pacientes com indicação de internação (utilizar CURB-65, CRB-65 e/ou PSI/PORT), além de considerar contexto clínico e social.

- **Uso endovenoso (antimicrobianos):**

Ceftriaxona 1g F/A (dose habitual: 2g/dia)
Reconstituir cada frasco em 10 mL de água destilada. Diluir em 100 ml de soro fisiológico 0,9% e infundir em 30 minutos a 1 hora uma vez ao dia por 7 dias.

E

Azitromicina 500mg F/A
Reconstituir em 4,8 mL de AD. Diluir em 250 mL de SF 0,9% e infundir em 60 minutos uma vez ao dia por 5 dias.



ROTINA CLÍNICA

PNEUMONIA

Também pode-se utilizar quinolona em monoterapia.

- **Uso endovenoso (antimicrobiano):**

Levofloxacino 500 mg injetável 5mg/mL - Frasco de 100mL

Não é necessário reconstituição. Infundir em 60 minutos uma vez ao dia por 7 dias.

Nestes casos, recomendamos que os sintomáticos sejam administrados pela via parenteral (EV, preferencialmente).

- **Uso endovenoso (sintomáticos):**

Dipirona 1 g injetável ---- 1 ampola

Diluir o conteúdo de 1 ampola em 8 ml de soro fisiológico 0,9% e infundir em bolus lento (2 minutos) de 6/6h em caso de dor e/ou febre.



PNEUMONIA

- **Uso endovenoso (sintomáticos):**

Bromoprida 10 mg injetável ---- 1 ampola

Diluir o conteúdo de 1 ampola em 8 ml de soro fisiológico 0,9% e infundir em bolus lento (2 minutos ou mais) de 8/8h em caso de náuseas e/ou vômitos.

Para evitar reação extrapiramidal, pode-se diluir em 100 mL de SF 0,9% e infundir por 15 a 20 minutos.

Alternativas:

Ondansetrona 2 mg/ml ---- 1 Ampola

Diluir o conteúdo de 1 ampola em 10 ml de SF 0,9% e infundir EV em 30 segundos.

Dramin B6 DL injetável® ---- 1 ampola

Diluir o conteúdo de 1 ampola em 10 ml de SF 0,9% e infundir EV em 02 minutos.



ROTINA CLÍNICA

OSELTAMIVIR

Indicações segundo o Protocolo de Tratamento de Influenza 2017 do Ministério da Saúde:

SRAG;

Grávidas em qualquer idade gestacional;

Puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal);

Adultos ≥ 60 anos;

Crianças < 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, especialmente as menores de 6 meses com maior taxa de mortalidade);

População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso;

Pneumopatias (incluindo asma);

Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica).



ROTINA CLÍNICA

OSELTAMIVIR

Nefropatias;

Hepatopatias;

Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);

Distúrbios metabólicos (incluindo DM);

Transtornos neurológicos que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, Síndrome de Down, atraso de desenvolvimento, AVC ou doenças neuromusculares);

Imunossupressão (incluindo medicamentosa ou pelo vírus da imunodeficiência humana);

Obesidade (IMC $\geq$ 40 em adultos);

Indivíduos menores de 19 anos em uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de Síndrome de Reye).



ROTINA CLÍNICA

OSELTAMIVIR

Detalhe: o início do tratamento deve ocorrer preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas.

Como prescrever?

- **Uso oral:**

Fosfato de Oseltamivir 75 mg ---- 1 caixa

Tomar 1 cápsula de 12/12h por 5 dias.

Importante: Indivíduos que apresentem sintomas de gripe devem evitar sair de casa em período de transmissão da doença (podendo ser por um período de até 7 dias após o início dos sintomas). Orientar o afastamento temporário das atividades até 24 horas após cessar a febre sem a utilização de medicamento antitérmico.



ROTINA CLÍNICA

PAXLOVID

Composição: Nirmatrelvir (300 mg) e Ritonavir (100 mg).

Indicações: Tratamento da Covid-19 em adultos que **não** requerem oxigênio suplementar e que apresentam **risco aumentado** de progressão para Covid-19 grave. O medicamento deve ser administrado, assim que possível, após resultados positivos de teste viral direto de SARS-CoV-2, e no prazo de **até 5 dias após o início dos sintomas**.



ROTINA CLÍNICA

PAXLOVID

Como prescrever?

A dose recomendada é de 2 comprimidos de nirmatrelvir com 1 comprimido de ritonavir por via oral duas vezes ao dia (de manhã e à noite) por 5 dias. O blister para cada dia de tratamento está dividido em duas seções de cores diferentes para indicar quais os comprimidos que devem ser tomados a cada hora do dia – um lado para a dose da manhã (AM) e o outro lado para a dose da noite (PM).

- **Uso oral:**

Nirmatrelvir + ritonavir 300/100 mg

Tomar a dose recomendada de 12/12 horas por 5 dias.



ROTINA CLÍNICA

ISOLAMENTO

Resfriado: varia na literatura. Ideal é manter isolado enquanto persistem os sintomas e liberar do isolamento após 24h de melhora importante do quadro. Na prática, varia entre 2 a 5 dias desde o início dos sintomas.

Influenza/Covid-19: varia na literatura, mas a maioria das referências recomenda entre 5 a 7 dias de isolamento respiratório desde o início dos sintomas (pelo menos 24h de melhora importante dos sintomas).

Vale citar: recomenda-se que o paciente utilize **máscara cirúrgica** e **evite** contato com **idosos** e **imunossuprimidos** durante o período dos sintomas.



TESTAGEM

Influenza: podem ser coletadas secreções de nasofaringe para realização de **teste rápido** ou **RT-PCR (padrão-ouro)**. O RT-PCR deve ser coletado em até (no máximo) 7 dias após o início dos sintomas.

Covid-19: pode ser realizado **teste rápido** ou **RT-PCR (padrão-ouro)**. Existem divergências na literatura, mas nas que verificamos, recomenda-se que o RT-PCR seja coletado em até (no máximo) 7 dias após o início dos sintomas.

